

Băng Nâng Giữa Niệu Đạo (cho Tiểu Không Kiểm Soát Khi Gắng Sức)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật nhanh, hiệu quả cao cho tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Băng nâng giữa niệu đạo (mid-urethral sling) là phẫu thuật phổ biến nhất để điều trị **tiểu không kiểm soát khi gắng sức ở nữ** — rò rỉ nước tiểu khi ho, cười, nâng vật nặng hoặc tập thể dục. Một dải lưới mảnh được đặt bên dưới phần giữa niệu đạo để nâng đỡ, giúp niệu đạo đóng lại khi áp lực tăng. Thủ thuật nhanh, thường thực hiện ngoại trú, hiệu quả cao và bền vững.

Về Ca Phẫu Thuật Này

Qua một vết mổ nhỏ bên trong âm đạo, một dải lưới mảnh được đặt **không căng** bên dưới phần giữa niệu đạo như một chiếc võng. Khi bạn ho hoặc gắng sức, niệu đạo tựa vào băng nâng và vẫn đóng lại. **Không cần thao tác gì** sau đó — thiết bị tự hoạt động. Có nhiều đường đặt khác nhau (sau xương mu và qua lỗ bịt) và băng nâng “mini” một vết mổ; bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn phương án phù hợp nhất cho bạn.

Về Dải Lưới

Băng nâng giữa niệu đạo tổng hợp là một trong những phẫu thuật **được nghiên cứu nhiều nhất** trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ, với bằng chứng vững chắc về tính an toàn và hiệu quả lâu dài. Dải lưới này **khác hoàn toàn** với lưới qua âm đạo dùng cho sa tạng chậu đã bị FDA cảnh báo. Nếu bạn không muốn dùng lưới tổng hợp, băng nâng làm từ **mô của chính bạn** (băng nâng cân tự thân) là một lựa chọn thay thế.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò rỉ nước tiểu khi áp lực tăng — ho, cười, nâng vật.

Băng nâng giữa niệu đạo

Dải lưới nâng đỡ phần giữa niệu đạo.

Không căng

Băng nâng nằm bên dưới niệu đạo mà không siết chặt.

Sau xương mu / qua lỗ bịt

Hai đường đặt băng nâng; cả hai đều hiệu quả.

Băng nâng tự thân

Băng nâng làm từ mô của chính bạn thay vì lưới tổng hợp.

Lộ lưới

Biến chứng không thường gặp khi một phần lưới trở nên nhìn thấy được; có thể điều trị.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê (toàn thân hoặc tùy sống) nên bạn không cảm thấy gì trong khi mổ, và thường hoàn thành trong dưới 30 phút. Hầu hết bệnh nhân **về nhà trong ngày** với cảm giác êm nhẹ và có thể nhanh chóng trở lại hoạt động nhẹ.

Cách Chuẩn Bị

- Tuân theo **hướng dẫn gây mê** (nhịn ăn, ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng; đôi khi kiểm tra chức năng bàng quang trước.
- Nhờ người đưa đón; dự kiến sinh hoạt nhẹ trong vài tuần.

Quá Trình Phẫu Thuật

1. Bạn được gây mê hoặc gây tê; kháng sinh được dùng trước.
2. Một vết mổ nhỏ trong âm đạo được thực hiện và dải lưới được đặt không căng bên dưới phần giữa niệu đạo.
3. Các điểm thoát nhỏ (trên xương mu hoặc ở bên) tự lành; vết mổ âm đạo được khâu lại.
4. Bạn thường được yêu cầu đi tiểu trước khi về nhà để xác nhận bàng quang tháo được.

Sau Phẫu Thuật

- Ê nhẹ và chảy ít máu là bình thường.
- **Tránh nâng vật nặng, gắng sức và quan hệ tình dục trong khoảng 6 tuần.**
- Đôi khi cần ống thông ngắn hạn nếu lúc đầu tiểu khó.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không thể đi tiểu** hoặc cảm thấy bàng quang không tháo hết
- Sốt hoặc chảy máu nhiều
- Đau ngày càng nặng hơn, hoặc sau này đau khi quan hệ hoặc ra dịch âm đạo (có thể liên quan đến lưới)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Băng nâng giữa niệu đạo nâng đỡ niệu đạo để ngăn rò rỉ khi gắng sức — nhanh, ngoại trú, hiệu quả cao, không cần thao tác sau đó.
2. Dải lưới này được nghiên cứu kỹ và khác với lưới sa tạng chậu đã bị thu hồi; băng nâng mô tự thân là lựa chọn nếu bạn muốn.
3. Tránh nâng nặng và quan hệ ~6 tuần. Gọi ngay nếu không tiểu được, sốt, hoặc sau này đau hay ra dịch âm đạo.